

赤脚医生教材

青海版



“赤脚医生”教材

(内部试用)



青海省《赤脚医生教材》编委会

一九七〇年三月

敬 祝

毛主席万寿无疆

最 高 指 示

**把医疗卫生工作的
重点放到农村去。**

一切为了
人民健康

毛
泽东

救死扶傷、寧死

革命的人道主義

1941年

團結新老中西各部分
醫藥衛生工作者，組成
鞏固統一戰線，為開展
偉大的人民衛生工作
而奮鬥

毛澤東

動員起來
講究衛生
減少疾病
提高健康水平
粉碎敵人的細菌戰爭

毛澤東

江陰神公

江陰神公

江陰神公
江陰神公
江陰神公

江陰神公
江陰神公
江陰神公

江陰神公
江陰神公
江陰神公

江陰神公
江陰神公
江陰神公

江陰神公
江陰神公
江陰神公

最高指示

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

备战、备荒、为人民。

前言

春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。无产阶级文化大革命伟大胜利的凯歌响彻云霄，毛泽东思想阳光普照祖国大地。全国亿万军民在以毛主席为首~~的党中央~~的党中央的领导下，高举“九大”团结、胜利的旗帜，进一步用毛主席关于无产阶级专政下继续革命的理论武装头脑，满怀革命豪情，以战斗步伐跨进了伟大的七十年代，去争取更大的胜利。

遵照毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的教导和“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针。广大的革命医疗卫生人员，高举毛泽东思想伟大红旗，狠批了叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在卫生部门代理人的反革命修正主义医疗卫生路线，坚决贯彻落实毛主席光辉的“六·二六”指示，深入农村、牧区、工矿，为工农牧群众防病治病，接受工人、贫下中农（牧）的再教育；深受贫下中农（牧）欢迎的合作医疗制度，正在巩固发展；一支新型的“赤脚医生”队伍，正在茁壮成长；新医疗

法和采集、利用中草药的群众运动，正在兴起；广大农村、牧区的防治网正在形成，“一无医，二无药”的落后状况，正在改变。卫生战线发生了深刻的革命变化。这是毛主席“六·二六”指示光辉思想的伟大胜利，是毛主席无产阶级卫生路线的伟大胜利，是无产阶级文化大革命结出的丰硕成果。

我们怀着对毛主席革命路线的深厚无产阶级感情，编写了这本《赤脚医生教材》。根据我省的实际情况，为了适应战备的需要，有助于培训和提高“赤脚医生”及巩固发展合作医疗制度，在医学教育改革与总结过去医学教育工作的基础上，学习了各地出版的医药卫生书刊，本着理论联系实际的教学原则，力求做到中西医结合，土洋结合，重点突出农村、牧区地方病、常见病、多发病，还收集整理了一部分验、简、廉的中药方、土方供参考。新医疗法已出版了两册，不再编入。

由于我们活学活用毛泽东思想很不够，缺乏工作经验，深入农村、牧区实际很差，加之编写时间又较仓促，所以，此教材仅作内部试用，~~其中难免有错误之处~~，敬希广大的革命医疗卫生人员及读者批评指正，使本教材在实践中不断得到改进和提高。

青海省《赤脚医生教材》编委会

一九七〇年三月

目 录

內 科 部 分

物理诊断基本知识	1
附 X 綫检查基本知识	16
常见症状鉴别	25
一、发热	26
二、昏迷	30
三、呕吐	32
四、腹泻	33
五、腹痛	34
六、便血	36
七、肝脾肿大	38
八、黄疸	39
九、腹内包块	41
十、水肿	43
十一、腹水	44
十二、胸痛	45
十三、呼吸困难与发紺	47
十四、血尿	48
十五、头痛	49
十六、惊厥	51

内科疾病	52
第一章 呼吸系统疾病	52
第一节 上呼吸道感染	52
第二节 支气管炎	54
第三节 支气管喘息	57
第四节 大叶性肺炎	60
第五节 肺脓肿	64
第六节 支气管扩张症	68
第七节 气胸	71
第二章 结核病	72
第一节 肺结核	73
第二节 渗出性胸膜炎	82
第三节 支气管内膜结核	84
第四节 结核性腹膜炎	84
第五节 肠结核	85
第六节 结核性脑膜炎	86
第三章 消化系统疾病	87
第一节 急性胃肠炎	87
第二节 慢性胃炎	89
第三节 溃疡病	91
第四节 胃肠神经官能症	97
第五节 急性胰腺炎	98
第六节 门静脉性肝硬化	101
第四章 循环系统疾病	108
第一节 风湿热(风湿病)	118
第二节 风湿性心脏瓣膜病	112
第三节 心力衰竭(心机能不全)	115

第四节	慢性肺原性心脏病	121
第五节	高血压病	124
第六节	冠状动脉粥样硬化性心脏病	127
第七节	心律失常	129
第八节	心包炎	133
第九节	高原病	137
第五章	泌尿系统疾病	144
第一节	弥漫性肾小球性肾炎	145
第二节	肾盂肾炎	149
第三节	慢性肾功能衰竭(尿毒症)	151
第四节	急性肾功能衰竭	153
第六章	血液系统疾病	156
第一节	贫血	156
第二节	紫癜	161
第三节	白血病	163
第七章	内分泌系统疾病和代谢疾病	166
第一节	甲状腺机能亢进症	166
第二节	糖尿病	169
第三节	痛风	174
第八章	运动系统疾病	178
	类风湿性关节炎	178
第九章	中毒性疾病	180
第一节	有机磷农药中毒	182
第二节	一氧化碳中毒	184
第三节	镇静、安眠药类中毒	185
第十章	神经系统疾病和精神疾病	187
第一节	神经官能症	187

第二节	癲癇	190
第三节	急性腦血管病	193
第四节	多发性神經炎	198
第五节	面神經炎	200
第六节	精神病	201
附:	神經系統检查法	207
第十一章	内科传染病	218
第一节	流行性感冒(流感)	218
第二节	伤寒	220
第三节	菌痢	222
第四节	阿米巴病	224
第五节	传染性肝炎	228
第六节	布魯氏菌病(波状热)	233
第七节	斑疹伤寒	238
第八节	鼠疫	240
附:	預防接种	243
常见急症的抢救		246
一、	周围循环衰竭	246
二、	呕血	251
三、	咯血	254
四、	狂躁及惊厥	255
五、	呼吸衰竭	257
六、	心脏驟停与复苏	258
七、	电击伤	260
八、	溺水	262
诊疗技术操作常规		263
一、	皮內過敏試驗	263

二、肌肉注射.....	264
三、靜脉穿刺抽血或注药.....	265
四、靜脉滴流法.....	265
五、輸血术.....	266
六、鼻飼法.....	268
七、洗胃法.....	268
八、灌腸法.....	269
九、导尿术.....	270
十、消毒中段尿的留法.....	270
十一、胸腔穿刺术.....	271
十二、腹腔穿刺术.....	271
十三、腰椎穿刺术.....	272
十四、髂嵴及脊椎棘突穿刺术.....	273
常见化验诊断.....	274
第一章 常见化验检查法.....	274
第一节 血液检查法.....	274
第二节 尿液檢驗法.....	283
第三节 粪便检查法.....	292
第二章 常见化验检查的正常值及临床意义.....	295
第一节 血液检查.....	295
第二节 血液生化检查.....	298
第三节 尿液.....	300
第四节 便潜血.....	301
第五节 脑脊液.....	301
第六节 渗出液与漏出液区别.....	302
第七节 肝功能試驗.....	302

小 儿 科 部 分

第一章 小儿的基本知识.....	303
第一节 小儿的特点.....	303
第二节 小儿年龄的分期及其特点.....	305
第三节 小儿的生长和发育.....	307
第四节 小儿运动机能的发育概况.....	311
第二章 小儿主要解剖生理特点.....	312
第一节 呼吸系統.....	312
第二节 循环系統.....	313
第三节 乳儿消化器官.....	313
第四节 神經系統.....	314
第五节 末梢血液象.....	314
第三章 小儿的营养与喂养.....	314
第一节 热能的需要.....	315
第二节 营养的需要.....	316
第三节 小儿喂养的几种方法.....	318
第四章 儿科病历和体格检查.....	321
第一节 儿科病历特点.....	321
第二节 体格检查的特点.....	323
第五章 新生儿及其常见疾病.....	324
第一节 新生儿出生后的护理.....	324
第二节 新生儿时期的生理改变及护理.....	324
第三节 新生儿常見疾病.....	326
第六章 小儿常见营养缺乏病.....	336
第一节 营养不良及营养不良性浮肿.....	337
第二节 佝偻病.....	339

第三节	婴儿手足搐搦症	341
第四节	维生素甲缺乏症	343
第五节	坏血病	345
第七章	小儿常见的呼吸道疾病	346
第一节	急性上呼吸道感染	346
第二节	支气管肺炎	348
第八章	小儿常见消化系统疾病	354
第一节	消化不良	354
第二节	口腔炎	362
第三节	幽门肥大型狭窄	364
第九章	肠寄生虫病	367
第一节	蛔虫病	367
第二节	蛲虫病	369
第十章	小儿常见传染病	371
第一节	麻疹	371
第二节	流行性脑脊髓膜炎(流脑)	377
第三节	小儿细菌性痢疾	383
第四节	百日咳	389
第五节	脊髓灰质炎(小儿麻痹症)	392
第六节	水痘	397
第七节	流行性腮腺炎	399
第八节	小儿结核病	401
第十一章	小儿常见的的心脏及血液的疾病	409
第一节	新生儿循环系统的调整	409
第二节	先天性心脏病	410
第三节	小儿风湿病	414
第四节	营养性贫血	418

第五节	紫癜	421
第六节	白血病	423
第十二章	小儿常见的泌尿系统疾病	425
第一节	急性出血性肾小球肾炎	425
第二节	尿路感染	427
第三节	肾病综合征	428
第十三章	儿科急症及处理	430
〔附一〕	廿四种常用静脉点滴药物配伍禁忌表	437
〔附二〕	小儿常用药物剂量表	438
〔附三〕	小儿常用成药剂量表	454

外 科 部 分

第一章	外科基础	456
第一节	无菌消毒和手术条件的建立	457
第二节	手术前准备与手术后处理	461
第三节	水、电解质及酸碱平衡失调及其治疗	469
第四节	输血	475
第五节	麻醉	477
第六节	手术基本技术	498
第二章	急救法	506
第一节	静脉切开术	507
第二节	动脉输血	508
第三节	人工呼吸	508
第三章	感染	509
第一节	皮及皮下组织化脓性感染	512
附:	换药	519
第二节	脓毒败血症	521

第三节	淋巴系感染	522
第四节	急性乳腺炎	524
第五节	化脓性骨髓炎	525
第六节	化脓性关节炎	527
第七节	脓胸	529
第八节	颈淋巴腺结核	533
第九节	骨与关节结核	534
第十节	肾结核 (附: 男性生殖系统结核病)	538
第十一节	胸壁结核	541
第十二节	破伤风	542
第十三节	气性坏疽	546
第十四节	炭疽	551
第十五节	肝棘球蚴病	552
	附: 肝泡球蚴病	555
第四章	损伤	556
第一节	损伤概述	556
第二节	骨折	559
第三节	脱位	583
第四节	骨科几项操作技术	588
第五节	周围神经损伤	595
第六节	胸部损伤	599
第七节	腹部损伤	605
第八节	尿道损伤	607
第九节	膀胱破裂	608
第十节	肾损伤	612
第十一节	颅内损伤	613
第十二节	烧伤	623

第十三节 冻伤	634
第五章 手的外伤与感染	636
第一节 手部解剖特点	637
第二节 手外伤的处理	638
第三节 手的急性感染	643
第六章 战伤的急救	647
第一节 火器伤的处理原则	648
第二节 火器性长骨骨折的一般处理原则	652
第三节 火器性关节伤的一般处理原则	653
第四节 开放性颅脑火器伤	654
第五节 胸部战伤的急救	657
第六节 腹部战伤	659
第七节 战时周围血管的损伤	662
第八节 挤压伤综合症	665
第七章 急腹症	670
第一节 腹壁的局部解剖和腹壁切口	671
第二节 急性腹膜炎	675
第三节 急性阑尾炎	679
第四节 肠梗阻	688
第五节 溃疡穿孔腹膜炎	697
第六节 急性胆囊炎和胆石症	700
第七节 急性腹痛鉴别	705
第八章 肿瘤	707
第一节 良性肿瘤	718
第二节 恶性肿瘤	722
第九章 外科其他常见病	740
第一节 腹外疝	740

第二节	单纯性甲状腺肿	750
第三节	下肢静脉曲张	753
第四节	血栓闭塞性脉管炎	755
第五节	囊性乳腺病	757
第六节	胃、十二指肠溃疡病手术治疗	758
第七节	痔	762
第八节	肛門瘻	765
第九节	直腸息肉	768
第十节	睾丸鞘膜积液	769
第十一节	包茎与嵌頓包茎	771
第十二节	尿潴留	774
第十三节	膀胱結石	776
第十四节	尿道結石	777
第十五节	前列腺肥大症	778
第十六节	尿路肉阜	779
第十七节	隐睾症	780
第十八节	骨骼运动系統临床检查法	781
第十九节	腰痛	791
第二十节	膝痛	798
第二十一节	肋軟骨炎	801
第二十二节	腕手部狭窄性腱鞘炎	802
第二十三节	肱骨上髁炎	804
第二十四节	肩关节周围炎	805
第二十五节	鸡眼	807
第二十六节	胼胝	809
第二十七节	美克尔氏憩室	810
第二十八节	腸瘻	812

妇 产 科 部 分

产科.....	817
第一章 孕期保健.....	817
第一节 孕期检查（产前检查）.....	817
第二节 孕期卫生指导.....	822
第二章 正常分娩.....	823
第一节 正常分娩的临床经过和处理.....	823
第二节 紧急情况下正常分娩的处理.....	827
第三节 新生儿处理及急救.....	829
第三章 妊娠中毒症.....	830
第一节 早期妊娠中毒症.....	830
第二节 晚期妊娠中毒症.....	832
第四章 妊娠早期出血病.....	838
第一节 流产.....	838
第二节 输卵管妊娠.....	840
第三节 葡萄胎.....	845
第五章 妊娠晚期出血病.....	847
第一节 前置胎盘.....	847
第二节 胎盘早期剥离.....	851
第六章 异常胎位及其处理.....	855
第一节 头位异常.....	855
第二节 臀位.....	856
第三节 双胎.....	863
第四节 羊水过多症.....	864
第七章 难产.....	865
第一节 子宫收缩无力（子宫收缩力过弱）.....	865

第二节	横位	867
第三节	狭窄骨盆	869
第四节	子宫破裂	875
第八章	产后出血	876
第九章	产褥感染	881
第十章	妊娠合并心脏病	883
妇科		885
第一章	妇科常见症状及检查	885
第一节	妇科常见症状	885
第二节	妇科检查	888
第二章	女性生殖器炎症	889
第一节	盆腔炎	890
第二节	滴虫性阴道炎	899
第三节	霉菌性阴道炎	900
第三章	子宫脱垂	901
第四章	月经失调	904
第一节	功能性子宫出血	904
第二节	痛经	909
第五章	生殖器官常见的肿瘤	911
第一节	卵巢囊肿	911
第二节	子宫肌瘤	913
第三节	子宫颈癌	915
第四节	子宫体癌	917
计划生育		918
第一章	计划生育工作的意义及方法	918
第二章	节育方法	921
第三章	人工流产术	921

第四章 绝育方法	926
常用妇产科手术	929
第一章 会阴切开术及裂伤缝合术	929
第二章 产钳术	931
第三章 碎胎术	935
第一节 穿颧术	935
第二节 断头除脏术	936
第四章 刮宫术	940
第五章 引产术	943
第一节 引产前处理	944
第二节 药物引产法	944
第三节 器械并用药物引产法	946

皮 肤 科 部 分

第一章 皮肤组织学和生理学	949
第一节 皮肤组织学	949
第二节 皮肤生理学	951
第二章 皮肤病的药物治	952
第三章 皮疹的形态	957
第四章 变态反应性皮肤病	959
第一节 荨麻疹	959
第二节 丘疹性荨麻疹	961
第三节 湿疹	962
第四节 药疹	966
第五节 接触性皮炎	968
第五章 化脓性皮肤病	968
第一节 脓疱疮(黄水疮)	968

第二节	毛囊炎	970
第三节	癬和癬病	970
第六章	原因不明的皮肤病	972
第一节	銀屑病(牛皮癬)	972
第二节	盘状紅斑性狼疮	974
第三节	多形紅斑	975
第四节	結节性紅斑	976
第七章	霉菌性皮肤病	977
第一节	黃癬(秃疮)	977
第二节	发癬(白癬)	979
第三节	手足癬	980
第八章	皮肤神经官能症	982
第一节	神經性皮炎	982
第二节	皮肤瘙痒症	983
第九章	结核性皮肤病	984
第一节	寻常性狼疮	984
第二节	瘰癧性皮肤結核	985
第三节	硬結性紅斑	985
第十章	麻风病	986
第十一章	皮肤附属器疾病	990
第一节	皮脂溢性皮炎	990
第二节	寻常性痤疮(粉刺或壮疙瘩)	992
第三节	酒渣	993
第十二章	性病	993
第一节	梅毒	993
第二节	淋病	999
第十三章	皮肤科常用处方	1001

五官科部分

眼部.....	1009
第一章 概论.....	1010
第二章 视器的解剖学.....	1012
第三章 眼科检查法.....	1018
第四章 眼睑病.....	1021
第五章 泪器病.....	1026
第六章 结膜病.....	1028
第七章 沙眼.....	1035
第八章 角膜病.....	1040
第九章 虹膜、睫状体炎(虹睫炎).....	1049
第十章 白内障.....	1055
第十一章 青光眼.....	1057
第十二章 眼外伤.....	1063
耳部.....	1071
第一章 耳的解剖.....	1071
第二章 耳部疾病.....	1077
第一节 耵聍栓塞.....	1077
第二节 外耳道异物.....	1079
第三节 外耳道瘻.....	1080
第四节 急性化脓性中耳炎.....	1081
第五节 慢性化脓性中耳炎.....	1083
第六节 美尼尔氏症.....	1086
第七节 神经性耳聋.....	1087
第八节 聋哑症.....	1089
鼻部.....	1091

第一章 鼻的解剖	1091
第二章 鼻部疾病	1094
第一节 鼻外伤(鼻骨骨折).....	1094
第二节 鼻前庭皮肤炎.....	1095
第三节 鼻癭.....	1096
第四节 鼻腔异物.....	1096
第五节 鼻流血.....	1097
第六节 慢性鼻炎.....	1099
第七节 慢性鼻窦炎的.....	1101
第八节 鼻息肉.....	1104
咽喉部	1104
第一章 咽喉的解剖	1104
第一节 咽的应用解剖.....	1104
第二节 喉的应用解剖.....	1107
第二章 咽喉部疾病	1109
第一节 咽炎.....	1109
第二节 急性扁桃腺炎.....	1109
第三节 扁桃腺周围脓肿.....	1111
第四节 慢性扁桃腺炎.....	1112
第五节 喉炎.....	1115
第六节 急性喉阻塞.....	1116
第三章 气管和食管镜检查法	1122
第一节 气管镜检查法.....	1122
第二节 食管镜检查法.....	1123
第四章 气管和食管异物	1123
第一节 气管支气管异物.....	1123
第二节 食管异物.....	1125

口腔部	1125
第一章 牙齿概论	1125
第一节 牙的数目、名称及符号.....	1125
第二节 牙及牙周各部名称.....	1127
第三节 牙的形态.....	1128
第四节 乳牙与恒牙的区别.....	1129
第二章 龋齿	1129
第三章 牙髓炎	1131
第四章 牙周膜炎	1132
第五章 颌面部炎症	1134
第一节 急性化脓性根尖周围炎(急性牙槽脓肿).....	1134
第二节 颌骨骨髓炎.....	1135
第三节 颌面部蜂窝组织炎.....	1136
第四节 冠周炎.....	1137
第六章 拔牙术	1138
第一节 拔牙的适应症与禁忌症.....	1138
第二节 麻醉.....	1139
第三节 拔牙时麻醉的选择.....	1142
第四节 拔牙.....	1142
第五节 麻醉和拔牙的合并症及其处理.....	1145
第七章 口腔颌面部损伤	1146
第一节 颌面损伤特点.....	1146
第二节 口腔颌面部损伤.....	1147
第八章 牙周病	1150
第九章 下颌关节脱位	1151
第十章 口腔颌面部肿瘤	1152
第一节 唇癌.....	1153

第二节	舌癌	1154
第三节	涎腺混合瘤	1154
第四节	造釉細胞瘤	1155
第五节	牙源性囊肿	1156
第十一章	唇裂修复法	1157
第十二章	口腔疾病常见症状的鉴别诊断	1158

中 医 部 分

第一章	怎样认识和预防疾病	1163
第一节	必须以毛泽东思想统帅医疗实践	1163
第二节	坚持辩证唯物论认识论的观点	1164
第三节	疾病是可以认识和战胜的	1165
第四节	坚决贯彻执行预防为主方针	1166
第五节	怎样用中草药防病	1168
第二章	中医是怎样诊断疾病的	1171
第一节	四诊	1172
第二节	辨证论治	1178
第三节	中医治疗疾病的基本法则	1184
第三章	中医是怎样用药的	1186
第一节	中药的采集和炮制	1186
第二节	药性	1189
第三节	常用中草药	1191
一、	解表药	1191
二、	清热药	1193
三、	泻下药	1197
四、	利尿渗湿药	1199
五、	祛风湿药	1201

六、溫里祛寒藥	1203
七、行氣藥	1204
八、活血祛瘀藥	1205
九、止血藥	1207
十、止咳化痰藥	1208
十一、化濕醒脾藥	1210
十二、消食藥	1211
十三、軟堅藥	1212
十四、安神藥	1212
十五、平肝息風藥	1213
十六、芳香開竅藥	1214
十七、補益藥	1215
十八、收澀藥	1219
十九、殺蟲藥	1220
二十、外用藥	1221

第四章 中医是怎样处方的.....1221

第五章 针灸与按摩.....1225

第一节 針灸療法.....1225

第二节 耳針療法.....1271

第三节 按摩療法.....1274

第六章 新医疗法.....1276

第一节 新針療法.....1277

第二节 鹵碱療法.....1280

第三节 新罐療法.....1281

第四节 穴位埋綫療法.....1283

第五节 割治療法.....1285

第六节 挑治療法.....1287

第七节 水針疗法	1288
第八节 經穴疗法	1289
附：俞穴、募穴、郄穴部位及主証表	1291
附：簡易外治法	1293
第七章 传染病及寄生虫病	1297
流行性感胃	1297
流行性脑脊髓膜炎	1300
肺結核	1302
細菌性痢疾	1304
附：阿米巴痢疾	1307
传染性肝炎	1307
伤寒	1310
布氏杆菌病	1312
蛔虫病	1314
蟯虫病	1315
條虫病	1316
包虫病	1317
第八章 内科疾病	1318
感冒	1318
咳嗽	1321
哮喘	1324
肺癆	1328
出血	1330
呕吐	1336
泄泻	1338
便秘	1342
噎膈	1344

头痛	1347
胃脘痛	1350
胸痛	1355
胁痛	1357
中风	1359
眩晕	1362
心悸(怔忡)	1365
失眠	1367
水肿	1369
积聚	1373
消渴	1376
癲狂癩	1379
阳萎	1381
疝气	1383
遺精	1386
五淋	1388
癰閉	1393
瘰症	1395
大叶性肺炎	1398
肺气肿	1400
矽肺	1402
潰瘍病	1404
闌尾炎	1406
胆道蛔虫症	1408
胆囊炎	1411
胆石病	1415
腸梗阻	1417

高血压	1420
风湿性心脏病	1424
肺原性心脏病	1426
肾脏炎	1427
尿路感染	1430
泌尿系结石	1432
再生障碍性贫血	1434
血小板减少性紫癜	1436
几种食物中毒的解救	1438
附：农药中毒解救验方	1440
第九章 小儿常见病	1441
麻疹	1441
风疹	1444
水痘	1445
丹痧(猩红热)	1447
小儿肺炎	1449
白喉	1453
顿咳(百日咳)	1456
疟疾(流行性腮腺炎)	1459
小儿麻痹症	1460
鹅口疮	1462
小儿消化不良	1464
疳症	1468
遗尿	1471
惊风	1472
小儿弱症	1477
第十章 妇女常见病	1480

月經不調·····	1480
閉經·····	1486
崩漏·····	1488
痛經·····	1491
帶下·····	1493
妊娠嘔吐·····	1495
胎動不安、墮胎、滑胎（流產）·····	1497
子腫（妊娠水腫）·····	1500
子癰·····	1501
產後發熱·····	1504
惡露不下·····	1505
惡露不絕·····	1507
產後腹痛·····	1510
產後大便難·····	1513
乳汁缺少·····	1515
陰痒·····	1517
陰挺（子宮下垂）·····	1518
癥瘕·····	1520
脏燥（癰病）·····	1522
第十一章 外科疾病 ·····	1523
第一节 一般外科病 ·····	1523
一般痛·····	1523
乳痛·····	1525
乳岩（乳腺癌）·····	1527
疽·····	1529
流痰·····	1533
疔瘡·····	1534

癰	1538
丹毒	1539
瘰癧(頸淋巴腺結核)	1541
氣瘻	1542
脫疽	1543
臁瘡	1544
凍瘡	1545
燙傷	1546
破傷風	1547
狂犬病	1548
附：外科外用藥	1549
第二节 肛門病	1551
內痔	1551
外痔(贅皮外痔)	1553
血栓性外痔	1554
混合痔(內外痔)	1555
肛裂	1555
脫肛	1556
肛瘻	1557
第十二章 傷科	1558
第一节 骨折	1558
鎖骨骨折	1558
肋骨骨折	1559
肱骨干骨折	1560
肱骨髁上骨折	1561
前臂雙骨折	1562
橈骨下端骨折	1563

247	腕骨骨折	1563
65	股骨頸骨折	1564
71	股骨干骨折	1565
85	髓骨骨折	1566
81	脛腓骨骨折	1567
111	外踝骨折	1568
511	第五趾骨基底部骨折	1568
61	第三节·脱位	1568
7	下颌关节脱臼	1568
811	肘关节脱臼	1569
813	小儿桡骨头半脱位	1569
1011	髋关节脱臼	1570
11	第三节·伤筋(軟組織損傷)	1570
51	頸部伤筋	1570
111	肩部伤筋	1572
51	肘关节伤筋	1574
5111	肘部劳損(肱骨外上髁炎)	1575
6111	腕关节伤筋	1576
111	腕部劳損(狹窄性腱鞘炎)	1577
2611	捻发性腱鞘炎	1577
5111	筋聚(腱鞘囊腫)	1578
111	膝部伤筋	1578
111	踝关节伤筋	1580
101	第四节·腰痛	1582
1	第十三章·皮肤病	1590
111	湿疹	1590
111	风疹块(蕁麻疹)	1592

皮膚瘙癢病	1594
肛門瘙癢症	1595
牛皮癬	1595
癬	1597
黃水瘡(脓疱瘡)	1599
蛇丹(帶狀疱疹)	1600
結节性紅斑	1601
白癜風	1602
第十四章 五官病	1603
針眼(麦粒腫)	1603
暴發火眼(急性結膜炎)	1604
椒瘡及粟瘡	1605
流淚症	1606
聚星障	1607
瞳神缺損	1609
綠風障	1610
視物昏渺	1611
耳脓(化脓性中耳炎)	1612
鼻淵(副鼻竇炎)	1614
乳蛾(扁桃腺炎)	1615
梅核氣	1616
喉痹	1617
牙痛	1620
牙疳	1622
第十五章 附录	1624
第一节 常用中藥成藥	1624
外感燥火类	1624

风湿痹症类·····	1625
咳嗽类·····	1626
安神类·····	1627
舒肝理气类·····	1628
健脾和胃类·····	1628
痢疾、痔、便秘和淋症类·····	1629
补益类·····	1630
妇产疾患类·····	1631
儿科疾患类·····	1632
其它·····	1633
第二节 肛門检查法及痔瘻手术法·····	1635
第三节 中医葯歌选·····	1642

最 高 指 示

指挥员的正确的部署来源于正确的决心，正确的决心来源于正确的判断，正确的判断来源于周到的和必要的侦察，和对于各种侦察材料的联贯起来的思索。指挥员使用一切可能的和必要的侦察手段，将侦察得来的敌方情况的各种材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思索，然后将自己方面的情况加上去，研究双方的对比和相互的关系，因而构成判断，定下决心，作出计划，——这是军事家在作出每一个战略、战役或战斗的计划之前的一个整个的认识情况的过程。

內 科 部 分

物理診斷基本知識

每个医务工作者在刚进入临床工作接触病人时，首先要高举毛泽东思想伟大紅旗，做到“完全”、“彻底”为工、农、兵服务，在看病过程中应带着阶级斗争、路线斗争观点及无产阶级感情，发扬“救死扶伤，实行革命的人道主义”精神，全心全意地为人民服务。

“基础內科”是內科的入門課程，也是臨床醫學的一個基本課程；其目的是學會正確和熟練的掌握檢查病人的一些基本方法；它的內容包括：（一）問病史，（二）體格檢查，（三）化驗，（四）器械檢查等步驟和方法。

我們着重敘述前兩項內容（問診、查體），這是診察疾病最基本的方法。為了及時正確的治療傷病員，早期恢復傷病員的戰鬥力與勞動力，醫務工作者必須通過問診和體格檢查，取得必要的材料與情況，“加以去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的思索”，作出正確的診斷，然後才能訂出合理的治療措施。因此我們必須遵照毛主席“對工作的極端的負責任，對同志對人民的極端的热忱。”的教導，作好診斷工作。

一、問診 向病人問病情，了解疾病發生的經過。問診時要帶着無產階級感情，要體貼病人。問的越詳細、準確、周到對診斷的幫助越大。最好問病人自己，如昏迷病人可以問家屬及了解病情的人。要注意盡量讓病人自己說，避免一問一答的方法。問診內容如下：

1. 一般項目 姓名，年齡，性別，籍貫，成分，職業，政治面貌，現住地址等。

2. 主訴 病人感覺最痛苦的症狀（或體征）及病程時間。

3. 現病史 病人從發病的最初症狀開始，一直到來診時為止整個階段的發展和變化過程，即起病的時間，誘因或原因，有那些症狀，病症發生部位，性質，程度及其變化等，以及與本病有鑑別意義的症狀。還應該詢問發病後曾否診治過，用藥治療否，其效果如何，以供參考。

4. 既往史 詢問以前患過什麼病。

5. 月經、分娩史（見婦產科）。

6. 個人史 與職業病、地方病、傳染病有關的工作和生活

史；与本病有关的政治思想情况；很多劳动人民的慢性疾病和他們在旧社会遭受苦难的经历有关，例如飢餓、寒冷等，所以劳动人民的个人史不仅是我們对了解他們疾病的发生发展的必要材料，而且往往也是我們接受工农兵再教育、培养无产阶级感情的好教材。

7. 家族史 与本病有关的，如家中有无得同样传染病或遗传性疾病的人。

举 例

王××，男，23岁，沈阳市人，家庭成分貧农，职业工人，党员，現住沈阳市紅旗区反修路一段二里十四号。来診时间：1969年2月18日上午九时。

主訴：发冷、发烧、咳嗽、胸痛四天。

現病史：四天前因受凉后突然发冷、发烧，四肢关节酸痛不适，体温在39°C左右，按“感冒”治疗用“安乃近”九片无效，病情加剧感到右侧胸痛利害，咳嗽、咯痰有铁锈色痰，食欲不振，全身无力而来院就診。

既往史 既往身体健康。

根据病史，我們可以初步考虑到这病人是呼吸系統疾病，病变可能在右侧胸部，很可能是一个右侧肺部炎症性改变，然后再进一步作体格检查。

二、体格检查（查体） 体表部位临床划分法：为了把检查的结果准确的反映和记录下来，临床上常用人体表面一些天然标志点和一些假定的垂直和水平线，将体表划分成許多部位，（见图1—4）借以标志内部器官正常位置和境界，或痛点体征的部位及范围。

查体分四个步骤 望、触、叩、听。

通过这四个步骤进行全面检查，結合病史綜合分析，得到

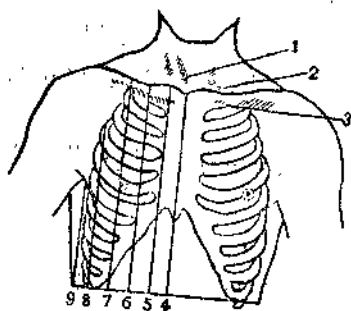


图1 体表前面划分法

1. 胸骨柄上窝 2. 锁骨上窝 3. 锁骨下窝 4. 前正中线 5. 胸骨线
6. 胸骨旁线 7. 乳线 8. 腋前线 9. 腋中线

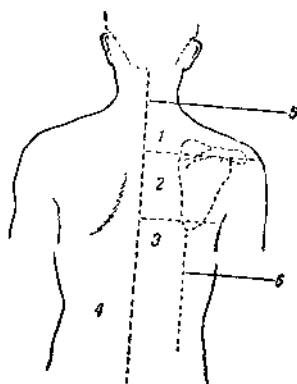


图2 体表背部划分法

1. 肩胛上窝 2. 肩胛间区 3. 肩胛下窝 4. 腰部 5. 脊柱线 6. 肩胛线

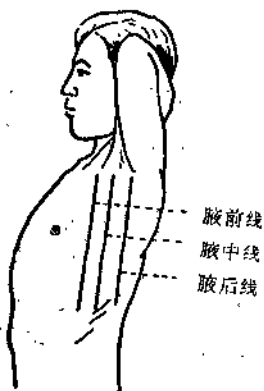


图3 腋线划分法

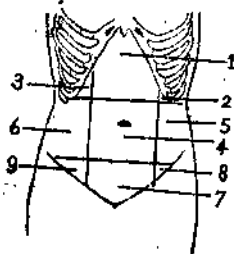


图4 腹部分区

1. 上腹部 2. 3. 左、右季肋部 4. 中腹部 5. 6. 左、右腰部 7. 下腹部 8. 9. 左右髂腹部

初步的判断。

望診 是一种較簡單而又重要的检查方法，例如看到有呼吸困難和口唇發紺的病人，就考慮是心脏或肺脏的疾病，要詳細檢查心脏和肺脏。按照毛主席教导的“由此及彼、由表及里”，以找到疾病的实质，最后得出正确的診斷。

触診 是借助手指（有时用全手）的感觉来判断所触脏器的特征（包括位置、大小、境界、表面性质、硬度、疼痛、移动性、震顫、波动等）的检查方法。

叩診 由于人体各部器官的弹性和含气量及其与邻近器官含气量的不同，利用指指叩診法，按其产生的不同音調来判断各器官的状态。在正常情况时叩打肺脏出現清音，叩打不含气的組織（心、肝、肌肉等）出現浊音，胃、腸为鼓音。

指指叩診法 叩診时将左手中指緊貼平放于被叩部位（勿加重压，以免影响被叩組織的震动）。右手手指稍屈曲以其中指灵活，垂直地利用腕关节的活动叩打左手中指的第二指节，叩打后将右手中指立即抬起。为了正确判断叩診音，有时須在同一部位进行数次同样力量的叩打。

听診 用直接或間接（听診器）法来听取体内发生的微弱声音。

伟大領袖毛主席教导我們說：**世界上怕就怕“認真”二字，共产党就最讲“認真”**。在进行查体时就要做到“認真”，避免遺漏体征，影响正确診斷。

现将查体的内容及順序叙述如下：

（一）一般情况

体温、脉搏、呼吸、血压、发育、营养、体位〔自动体位（活动自如），被动体位（病人为了減輕痛苦被迫采取的体位），如端坐呼吸見于严重呼吸困难的心脏病及肺部疾患〕。

面容与表情（安静、痛苦、恐惧、热性病容、慢性病容等）。

意识（清楚、神志不清、嗜睡、昏迷）及精神状态（兴奋、忧郁）等。

皮肤颜色（潮红、发紺、苍白、黄染、色素沉着）、出血点及皮疹，有无外伤遗迹等。

淋巴结（颈、腋下、腹股沟）有无肿大，其大小、压痛、硬度、移动度、瘰管、瘢痕等。

（二）头部检查

眼 眼睑（运动、下垂、水肿）；眼球（运动、突出）；结合膜有无充血、苍白；巩膜有无黄染；瞳孔形状、大小，两侧是否等大，对光反应是否存在。

鼻 阻塞，分泌物（性质、颜色、臭味）；付鼻窦（额窦及上颌窦）有否压疼。

耳 听力，分泌物，乳突有否压痛。

口腔 口唇（苍白、发紺、有无疱疹）；舌苔改变；粘膜有无出血点和溃疡；扁桃体的大小，是否充血，有无分泌物。

（三）颈部检查

强直、静脉怒张、肿物、气管的位置（将食指与中指放于胸骨柄上窝进行触诊，正常位于正中，胸膜粘连及肺不张时，气管移向患侧；胸腔大量积液，积气时气管向健侧移位）。甲状腺（肿大的甲状腺随吞咽运动而上下移动，注意其大小、硬度、有无结节、压痛、血管震颤、血管杂音）。

（四）胸部检查

1. 望诊 两侧胸廓是否对称，有无凹陷（一侧凹陷多见于胸膜粘连），有无隆起（一侧隆起可见于胸腔内有大量积液、积气，心前区局限性胸廓隆起，可见于发育成熟前心脏扩大的先天性心脏病病人）。有无桶形胸（多见于肺气肿）。

心尖搏动 它是心脏左心室的一部分，在心室收缩时，心尖冲击胸壁所引起的搏动。正常心尖搏动在左侧锁骨中线内第五肋间。

影响心尖搏动位置的病理因素：

心脏扩大 左心室肥大时心尖搏动向左下方移位，甚至可达到左腋前线；右心室肥大时心尖搏动只向左方轻度移位。

心脏异位 先天性右位心时，心尖搏动位于右侧。

胸部疾患 多量的胸腔积液或积气时，可使心尖搏动向对侧移位。严重的胸膜肥厚时，可使心尖搏动向同侧移位。

腹部疾患 腹腔内有大量液体，气体或巨大肿物时可使膈肌上升，心尖搏动亦因而上升。

2. 触诊

语颤 检查时将二手掌（或用手掌尺侧缘）平贴在胸廓的对称部位，请病人拉长声说“一”字，触诊者的手即有震颤感，这就是语颤。是由于声带的震动、声浪沿着气管、支气管、肺传到胸壁，使胸壁发生了震颤所产生的。肺部有炎症浸润，或肺组织实变时，语颤可以增强，如大叶肺炎、肺梗塞。如有影响声浪由声门传到胸壁的情况，可使语颤减弱或消失，如支气管堵塞，胸腔积液或积气、肺气肿等。

心尖搏动 触诊检查可更准确地确定心尖搏动的位置及范围（正常面积直径为2—2.5厘米），如望诊不能发现的，或看不清的心尖搏动，触诊时可以触及。

心脏细震颤（猫喘） 震颤的发生是由于血流，经过一个口径狭窄的部位，流到一个口径较宽的部位，或循着不正常的血流方向流动，发生旋涡，激动心壁而产生震动。

触诊所发现的震颤，与听诊所发现的杂音意义完全相同。但有杂音时不一定触到震颤。在发现震颤时，应注意其部位及

时间,通常在心脏弁口狭窄时,发现震颤的机会较多。例如二尖弁狭窄有时在心尖部,舒张期可触及细震颤。主动脉弁狭窄时在胸骨右缘第二肋间触及收缩期细震颤。

3. 叩诊

叩诊的顺序,可由肺尖开始进行对称性的叩诊自上而下,由前面转向侧面,最后检查背部(由肩胛间向肩胛下方)。

肺肝界 把左手中指平放于右侧肋间隙,由上往下叩,由正常肺脏清音变为浊音时,这个界限就是肺肝境界,正常在右侧锁骨中线第五肋间隙或第六肋。肺肝界下降可见于肺气肿,肺肝界上升可见于肝脓肿。肺肝界消失可见于胃腸穿孔。

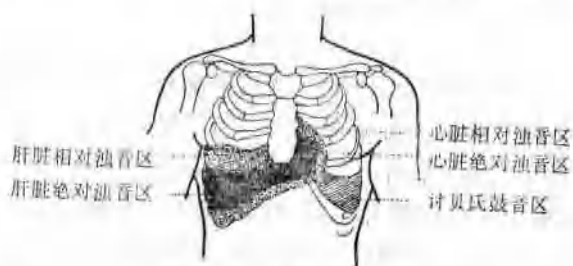


图5 正常胸部叩诊音区

胸部病理叩诊音

叩 诊 音	病 变	疾 病
浊音(实音)	1. 肺泡内含气量减少。 2. 胸腔积液或胸膜肥厚。	大叶肺炎, 肺不张。 渗出性胸膜炎, 胸膜肥厚。
过 清 音	肺含气量增加, 同时有弹性降低。	肺气肿。
鼓 音	胸腔积气	气胸。

心界 心脏为含血的器官叩诊时为浊音; 肺脏为含有气

体器官,叩诊为清音,所以用叩诊法,由心尖搏动所在的肋间,自外向内叩诊,由清音变为浊音处则为心脏左界。正常心左界在第五肋间左锁骨中线内 1.0 厘米左右。左心室增大时,心脏向左侧并向下增大,心左界超过左锁骨中线外。正常心左缘 2—4 肋间及心

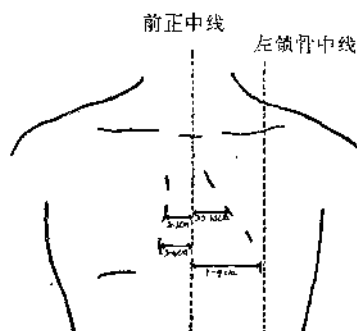


图 6 心脏相对浊音界

右缘叩诊意义不大。但有心包积液时,心右缘及左缘上部均增大(正常心右缘于 2、3 肋间在前正中中线外 2—3 厘米,左缘于第三肋间前正中中线外 3.5—4.5 厘米)。

4. 听诊 肺部听诊顺序与肺部叩诊相同。

肺泡呼吸音(正常呼吸音) 当空气进入肺泡时,肺泡壁由弛缓转为紧张状态,呼气时肺泡由紧张变为弛缓,这种肺泡弹性变化,可以发出一种较软而似有吹风性质的“夫”音,这就是肺泡呼吸音,在正常肺组织可以听到,吸气音较呼气音长。在肺气肿,胸腔积液,胸膜肥厚时呼吸音减弱。

支气管呼吸音 类似“哈”音。因呼气时声门裂隙较吸气时为狭,声音强长而高。正常在喉部,胸骨柄区及肩胛间第 3—4 胸椎水平处(气管分叉处)可听到。

病理性呼吸音

(1) 罗音 分干性罗音及湿性罗音。

干性罗音 产生于支气管。空气通过狭窄的支气管腔,或支气管腔内由于粘稠的分泌物伸展形成丝条被气流冲击振动而产生哨笛音或哮喘音。在吸气及呼气时皆可听到,往往在

呼气时較高而清晰。临床常見于支气管喘息。

湿性罗音(水泡音) 当气流通过带有稀薄分泌物的支气管时,引起液体的震动而发生水泡音,由于支气管口径不同,可出現大小不一致的湿性罗音。分大、中、小三种,临床常見于肺結核、肺淤血、肺炎、支气管扩张及重症肺結核。如肺泡內有少量液体存在时,在吸气末可听到細小的如捻发样的声音,称为捻发音。病理的多見于大叶肺炎。

(2) **支气管呼吸音** 在正常人喉头、气管、肩胛間区可听到支气管呼吸音。如在肺組織其他部位听到,就是病理的支气管呼吸音,或称管状呼吸音,見于肺組織实变时如大叶肺炎。

(3) **胸膜摩擦音** 正常胸膜滑潤,呼吸运动时不产生音响。当胸膜变为粗糙时出現摩擦音如胸膜炎早期及胸水吸收期。

心音听診部位 在临床上心脏听診区有五个部位,即二尖弁区、主动脉弁区、肺动脉弁区、三尖弁区、主动脉弁第二听診区(第五点)。具体部位見图7。

心音 正常的心脏可以听到二个性质不同的声音交替出現,称之为第一心音和第二心音。如何区别第一心音和第二心音,第一心音較长而音調較低,第二心音則較短而音調較高。第一心音与第二心音間的間隔較第二心音与下一次第一心音的間隔为短。第一心音的出現与心尖搏动在同一時間。第一心音产生在心脏的收縮期,第二心音在舒张期。第一心音在心尖部最清楚,第二心音在主动脉弁及肺动脉弁听診区最清楚。

(1) **心音的变化** 甲状腺机能亢进时,心音在各弁口都加强,胸壁厚或肺气肿时,心音减弱。心肌炎时第一心音

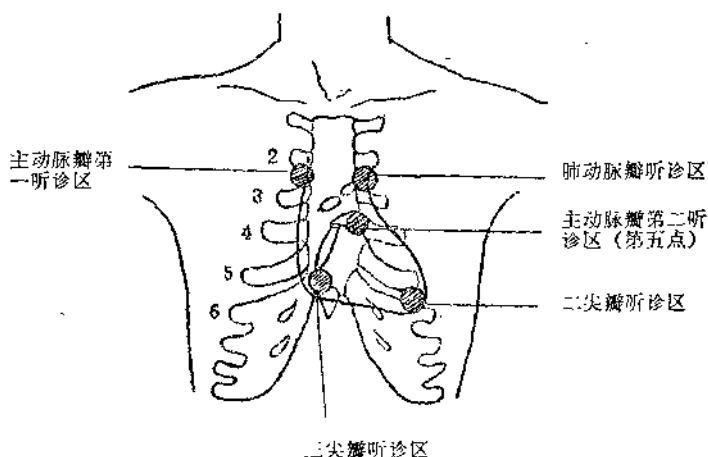


图7 心音听诊部位

减弱并变钝，同时心率快，呈胎心律。心包有积液时心音常是轻而远。二尖瓣狭窄时，二尖瓣的第一心音明显亢进。高血压病时主动脉瓣第二心音亢进。正常的心脏有时在第二心音之后出现第三心音，多见于小儿，心率正常。严重心肌病变，左心衰竭时可出现三个心音，此时心率快（每分钟 100 次以上），在心尖部位听到如跑马样的节律——奔马律。

（2）杂音 杂音的产生是由于血流经过狭窄处流到较宽大的地方，或由于血液逆流使血流产生旋涡，亦可由于血液粘稠度降低或血流速度的增快。在临床上常见有收缩期杂音，舒张期杂音，连续性杂音。听到杂音时应当根据杂音产生的部位、时间、性质、强度及传导方向来判断其临床意义。

收缩期杂音 在心脏收缩期，伴随第一心音同时出现吹风样杂音，有时该杂音掩盖了正常的第一心音。收缩期杂音分功能性和病理性二类。功能性杂音性质较柔和，部位比较